

PERICARDITE CHRONIQUE CONSTRICTIVE

Pr RABEARIVONY Nirina

PLAN

I. Généralités

II. Signes

III. Diagnostic

IV. Traitement

Conclusion

I. GENERALITES

1. Définition :

Affection inflammatoire chronique du péricarde avec **épaississement fibro-calcaire** responsable d'une gêne au remplissage ventriculaire (= adiaastolie)

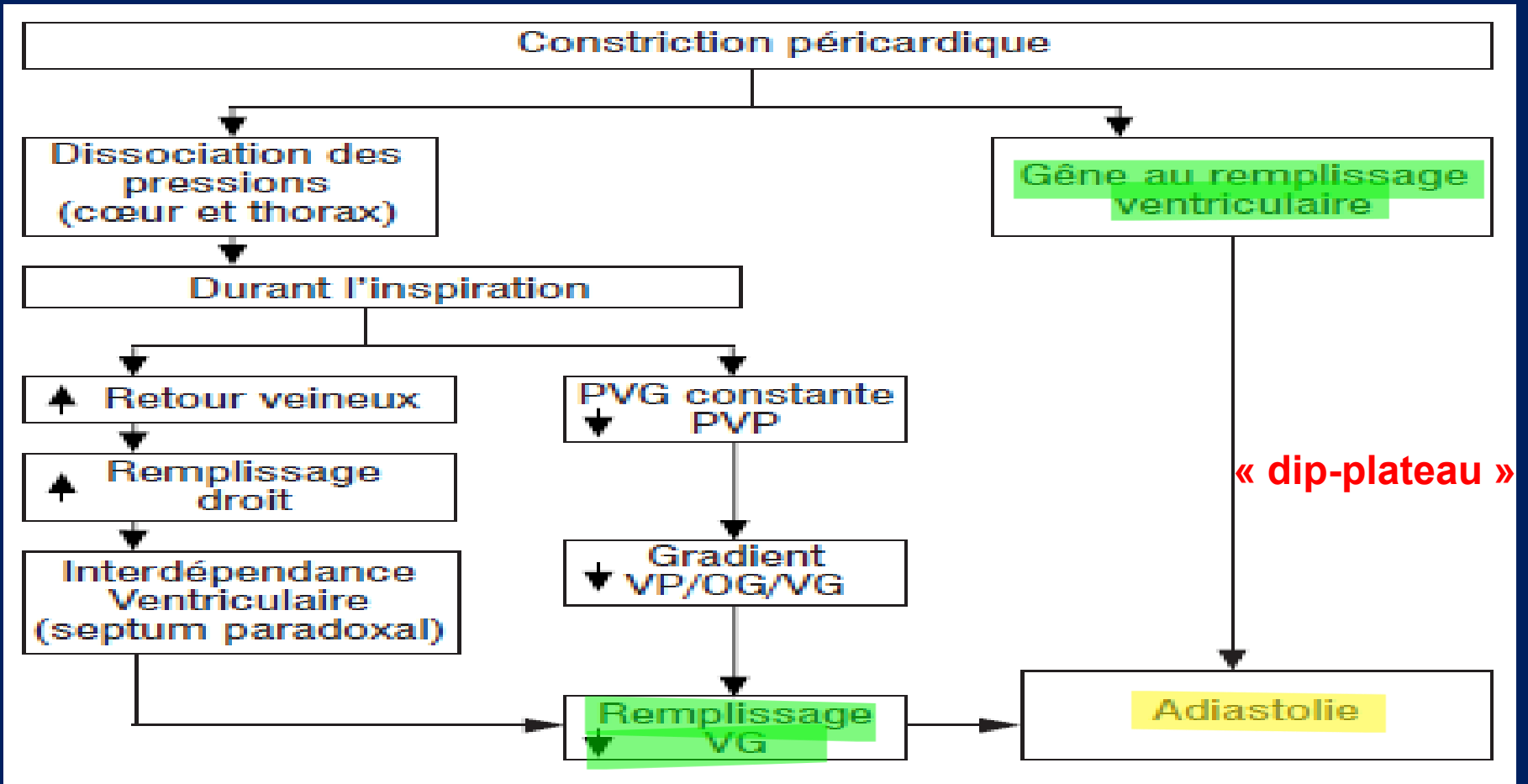
I. GENERALITES

2. Intérêts :

- **Fréquence : 0,5 à 2% des cardiopathies et 0,6% des chirurgies cardiovasculaires**
- **Mortalité élevée en absence de traitement chirurgical**
- **Survie de 70% à 10 ans si péricardectomie**

I. GENERALITES

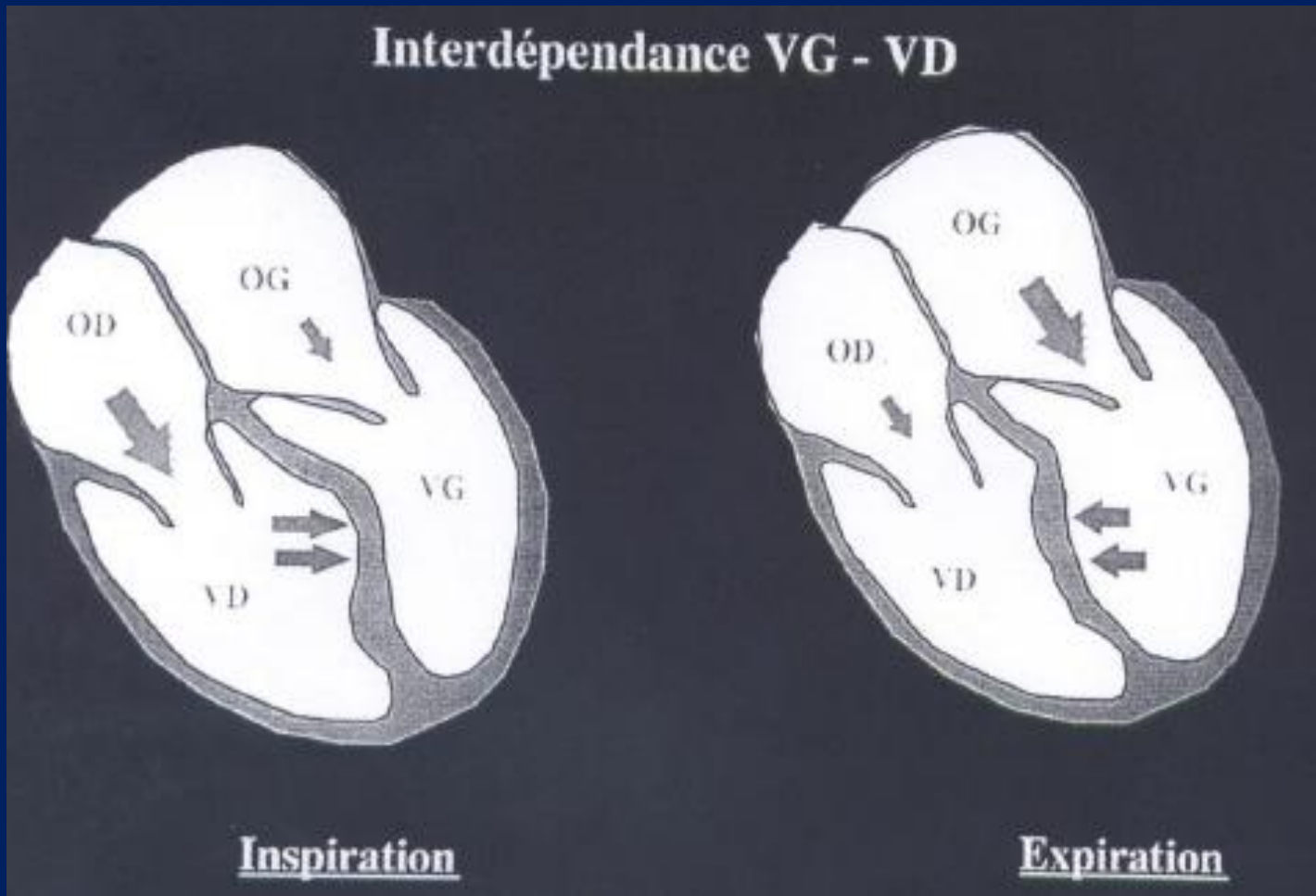
3. Physiopathologie :



Physiopathologie de la péricardite chronique constrictive. PVG. Pression dans le ventricule gauche. PVP. Pression veineuse pulmonaire. VP. Veines pulmonaires. OG. Oreillette gauche. VG. Ventricule gauche.

I. GENERALITES

3. Physiopathologie :



II. SIGNES

1. TDD : PCC symptomatique calcifiée de l'adulte

11. Signes cliniques

SF :

- **Dyspnée d'effort (85%)**
- **Dyspnée de décubitus (20 à 30%)**
- **Asthénie généralisée (30 à 50%)**
- **Hépatalgie d'effort (10 à 30%)**
- **Douleur thoracique, toux sèche (rares)**

II. SIGNES

1. TDD : PCC symptomatique calcifiée de l'adulte

11. Signes cliniques

SP :

- Normal (20%)
- Déviation du choc de pointe
- Tachycardie régulière
- Tension artérielle : abaissée, pincement différentielle
- Hépatomégalie douloureuse, TVJ, pleurésie

II. SIGNES

1. TDD : PCC symptomatique calcifiée de l'adulte

11. Signes cliniques

SP :

➤ **vibrance péricardique:**

bruit diastolique pathognomonique de la calcification péricardique

protodiastolique, maximum à l'apex, parfois vibrant, intense et claqué
(➔ impact de la colonne sanguine sur une paroi ventriculaire inextensible)

➤ **dédoubllement inspiratoire de B2**

II. SIGNES

1. TDD : PCC symptomatique calcifiée de l'adulte

11. Signes cliniques

SP :

➤ **Pouls paradoxal de KUSSMAUL:**

chute de plus de 15% (> 12 mm Hg) de la PAS en début d'inspiration non forcée

(augmentation inspiratoire du volume VD et bombement du SIV dans le VG réduisant son remplissage diastolique)

II. SIGNES

1. TDD : PCC symptomatique calcifiée de l'adulte

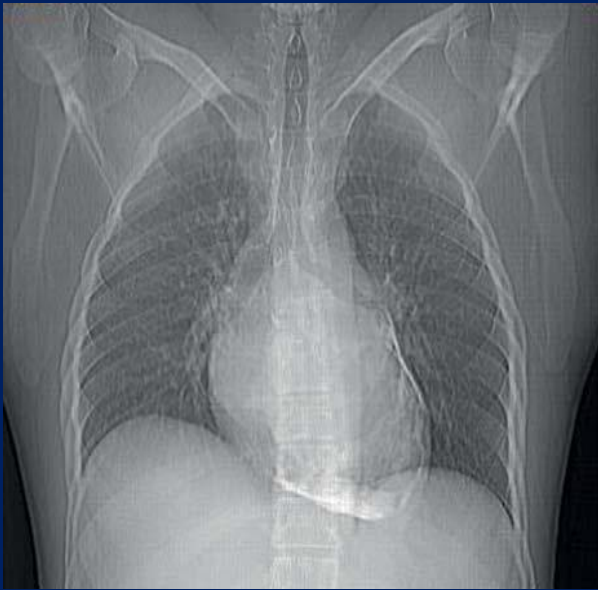
12. ECG :

- Fibrillation auriculaire (20% des cas)
- Onde P bifide
- Hypertrophie auriculaire bilatérale
- Micro-voltage des complexes QRS
- Anomalies diffuses de la repolarisation :
T plate ou $T < 0$

II. SIGNES

1. TDD : PCC symptomatique calcifiée de l'adulte

12. Radiographie thoracique de face et profil :



→ **calcifications** (mieux visibles sur le cliché de profil)
prédominant habituellement dans le sillon auriculo-ventriculaire

II. SIGNES

1. TDD : PCC symptomatique calcifiée de l'adulte

13. Echographie cardiaque transthoracique:

2D

- Epaissement péricardique
- Dilatation modérée des deux oreillettes et VCI
- Ventricules de taille normale
- Rupture de l'alignement entre Paroi post VG et OG +++



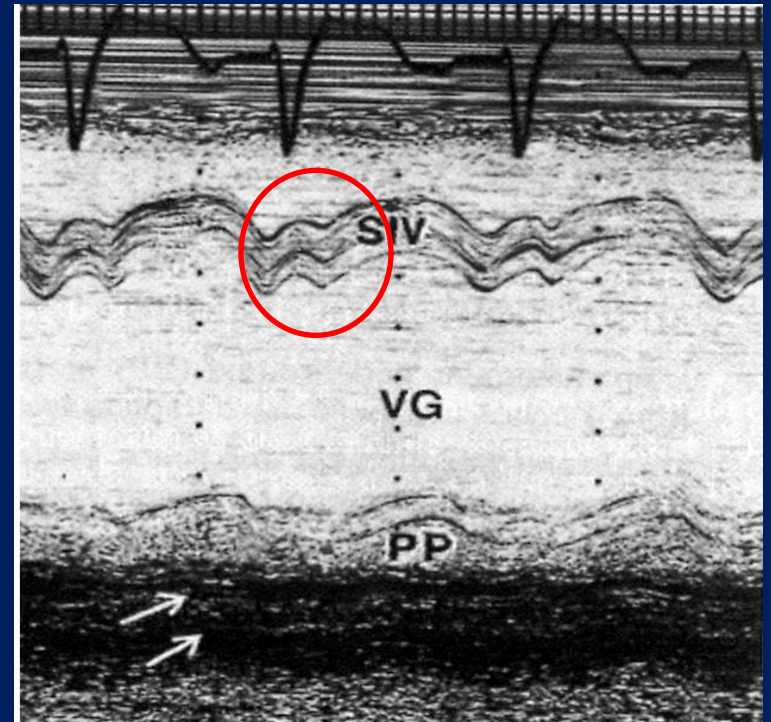
II. SIGNES

1. TDD : PCC symptomatique calcifiée de l'adulte

13. Echographie cardiaque transthoracique:

TM

- Mouvement paradoxal du SIV
- Mouvement plat « figé » de la PP

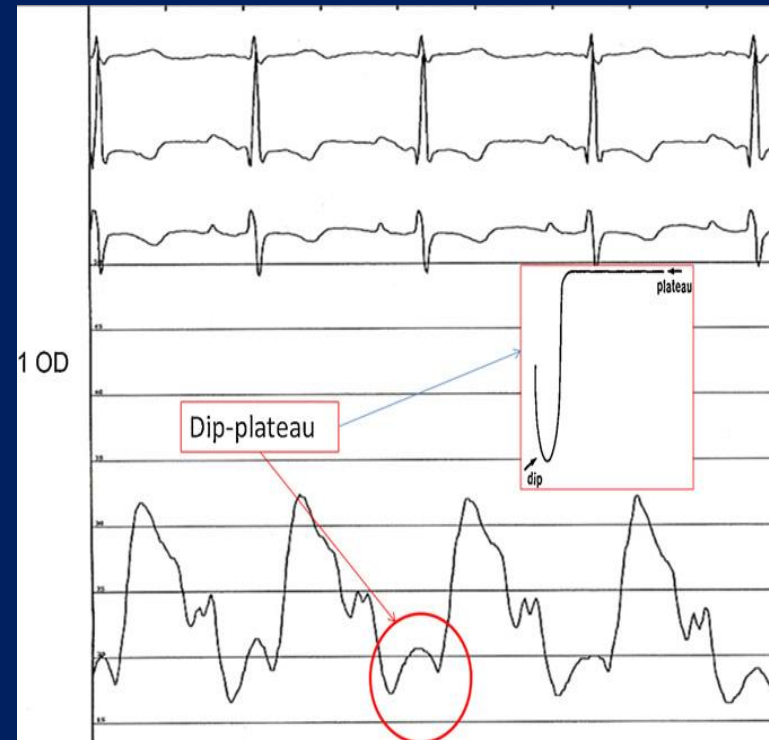


II. SIGNES

1. TDD : PCC symptomatique calcifiée de l'adulte

14. Cathétérisme droit :

- Augmentation et égalisation P° diastoliques des 4 cavités
- Diminution du débit cardiaque
- **Dip-plateau** P° VD



II. SIGNES

1. TDD : PCC symptomatique calcifiée de l'adulte

14. TDM et IRM cardiaque : Epaisseur ($> 6\text{mm}$) et calcification



II. SIGNES

1. TDD : PCC symptomatique calcifiée de l'adulte

16. Biologie :

- Syndrome inflammatoire biologique : NFS, VS, CRP
- Biopsie péricardique (fibrose ou calcification)

II. SIGNES

1. TDD : PCC symptomatique calcifiée de l'adulte

17. Pronostic :

- Sombre en absence de traitement (aggravation progressive)
- Survie à 10 ans = 70% (si traitement chirurgical)

II. SIGNES

2. Formes cliniques

21. Forme évolutive

- **Péricardite constrictive transitoire :**
 - **Tableau clinique et échographique de PCC**
 - **Inflammation péricardique active , intérêts IRM**
 - **se résorbe sous traitement anti-inflammatoire**

II. SIGNES

2. Formes cliniques

22. Forme avec épanchement péricardique (20-25%)

- Epanchement libre ou cloisonné
- Diagnostic différentiel difficile avec tamponnade
- Tuberculose +++

II. SIGNES

2. Formes cliniques

23. Forme selon le terrain

➤ Chez l'enfant :

- Même symptomatologie avec calcifications
- Tuberculose +++

II. SIGNES

2. Formes cliniques

24. Forme anatomique

➤ PCC fibreuse

- Epaississement et adhérence sans calcifications
- Clinique : 3^e bruit diastolique sourd non vibrant
- Echographie et IRM

II. SIGNES

2. Formes cliniques

25. Forme compliquée

➤ syndrome de PICK

Association:

- **Hypertension portale** (ascite, hépatomégalie splénomégalie, circulation collatérale)
- **Hypertension veineuse** (syndrome cave supérieur et syndrome cave inférieur)

III. DIAGNOSTIC

1. Diagnostic positif

- Signes cliniques : IVD ou dyspnée ...
- Echographie doppler (adiastolie)
- Histologie par biopsie péricardique

III. DIAGNOSTIC

2. Diagnostic différentiel

- **Causes non-cardiaques**
 - **Cirrhose hépatique**
 - **Atteintes rénales**
 - **Syndrome de BUDD-CHIARI**

III. DIAGNOSTIC

2. Diagnostic différentiel

➤ Causes cardiaques

- Cardiomyopathies restrictives
(amylose, hémochromatose)
- Infarctus du ventricule droit
- Fibrose endomyocardique et
endocardite fibroblastique de LOEFFLER

III. DIAGNOSTIC

3. Diagnostic étiologique :

- Tuberculose +++
- Constriction post-chirurgie cardiaque (pontage, valve ...)
- Constriction post-radiothérapie médiastinale (Hodgkin, poumons, seins,....) 5 à 10 ans après
- Autres causes rares : IRC, Lupus, PR, traumatisme thoracique, infections (bactériennes et virales)
- Idiopathique

III. DIAGNOSTIC

4. Diagnostic de gravité : TERMINALE

- Cachexie
- Fibrillation auriculaire ou flutter auriculaire
- Faible débit cardiaque (index cardiaque $< 1,2\text{L/m/min}$) au repos
- Hypoalbuminémie
- Hyponatrémie et insuffisance rénale

IV. TRAITEMENT

1. Buts

- Guérir la péricardite chronique
- Donner un confort de vie aux patients

IV. TRAITEMENT

2. Moyens

22. Médicamenteux

- **Diurétiques (lors des poussées)**
- **Traitement antituberculeux ou antibiotiques**
- **Corticoides ou immunosuppresseurs (maladies de système)**

IV. TRAITEMENT

2. Moyens

23. Chirurgicaux

Péricardectomie (décortication + décalcification)

- partielle ou totale
- seul traitement efficace et logique
- mortalité péri-opératoire 10 %
- survie à 10 ans = 70 %

IV. TRAITEMENT

3. Résultats :

- **Nette amélioration fonctionnelle (80 à 90% des cas)**
- **Mortalité hospitalière (10%)**
- **Risque de survenue d'une défaillance cardiaque congestive après une péricardectomie (10 à 35%)**

CONCLUSION

- **Péricardite chronique constrictive : rare**
- **Diagnostic difficile**
- **Pronostic sévère en absence de traitement**
- **Traitement = chirurgical (péricardectomie)**